



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA

BÁO CÁO THỰC HIỆN BÀI TẬP

MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CHỦ ĐỀ:

**“ỨNG DỤNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ (EHR) VÀ VAI TRÒ
CỦA CÔNG NGHỆ SỐ, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG
NGÀNH CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG”.**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA



BÁO CÁO THỰC HIỆN BÀI TẬP

MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chủ đề:

Ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử (Electronic Health Records - EHR) và Vai trò của Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence -AI) trong ngành chăm sóc điều dưỡng

Sinh viên: *Trịnh Gia Linh*

Lớp: *QH2025.DD*

Ngành: *Điều dưỡng.*

Môn học: *Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.*

1 Mở đầu.

Là sinh viên đang theo học ngành điều dưỡng, em nhận thấy **hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR)** là một **hệ thống lưu trữ thông tin sức khỏe của bệnh nhân dưới dạng kỹ thuật số**. Điểm quan trọng của EHR là chia sẻ được dữ liệu giữa nhiều cơ sở y tế khác nhau thông qua các mạng lưới thông tin, giúp việc chăm sóc bệnh nhân trở nên liên tục và hiệu quả hơn. [1] (Gunter TD, Terry NP, March 2005).



Hình 1: Sơ đồ hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (Tạo bằng AI - Gemini).

Dữ liệu trong EHR được lưu trữ rất đa dạng: từ thông tin nhân khẩu học, tiền sử bệnh, thuốc men và dị ứng, tình trạng tiêm chủng, kết quả xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán (như X-quang, CT...), đến các chỉ số sinh tồn, cân nặng, tuổi tác và cả thông tin thanh toán khám chữa bệnh. Nhờ vậy, nhân viên y tế nói chung sẽ có cái nhìn toàn diện về tình trạng bệnh nhân [6] (Ze Luan et al (Jilin University, Trung Quốc), 2023).

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, dữ liệu lớn (big data) [2] (Wang, Y., Kung, L., & Byrd, T. A., 2018) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đã tạo ra nhiều cơ hội mới để cải thiện hiệu quả quản lý và cung cấp dịch vụ y tế, đặc biệt là các thiết bị thông minh cầm tay như Smart phone đã phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp trong xã hội hiện đại. Từ đó, EHR đã được xem là công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc. Việc tích hợp dữ liệu giúp bác sĩ và điều dưỡng dễ dàng phát hiện, phân loại bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa nhập viện ở những người có nguy cơ cao. Là sinh viên điều dưỡng, em thấy đây là một lợi ích lớn vì nó giúp Điều dưỡng phối hợp tốt hơn với Bác sĩ trong việc theo dõi và chăm sóc bệnh nhân.

Ngoài ra, EHR còn khắc phục hạn chế của hồ sơ giấy truyền thống: không cần mất thời gian tìm kiếm, dữ liệu luôn được cập nhật và dễ đọc. Hệ thống cũng tạo điều kiện cho sự giao tiếp cởi mở giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư và bảo mật. Một điểm em thấy rất đáng chú ý là EHR giúp tiết kiệm chi phí, giảm nguy cơ thất lạc hồ sơ và hạn chế việc trùng lặp dữ liệu.

Với sự phát triển của **Internet băng thông rộng 4G/5G** cùng với trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh trong vài năm gần đây, đã tạo ra cơ hội ứng dụng cao hơn EHR không chỉ còn là một núi dữ liệu khổng lồ mà vì dữ liệu trong EHR có thể được tìm kiếm và phân tích, nó không chỉ phục vụ chăm sóc cá nhân mà còn hỗ trợ nghiên cứu y tế trên quy mô dân số, được tự động hóa sàng lọc dựa trên AI. Điều này mở ra cơ hội để ngành điều dưỡng và y học nói chung phát triển các phương pháp chăm sóc mới, cải thiện kết quả điều trị lâu dài cho bệnh nhân.

2 Phương pháp luận thực hiện chủ đề

Để thực hiện bài luận về chủ đề: “**ỨNG DỤNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ (EHR) VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SỐ, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG**”, tài liệu từ nhiều nguồn học thuật khác nhau được tiến hành tìm kiếm và tổng hợp như sau:

- ✓ **Cơ sở dữ liệu học thuật:** Chủ yếu dùng Google Scholar. Truy cập CSDL thư viện trường qua cổng thông tin nội bộ.
- ✓ **Tạp chí khoa học chuyên ngành:** Tìm trên PMC (PubMed Central), Frontiers, BMC Nursing, Canadian Journal of Nursing Informatics, Journal of Advanced Nursing.
- ✓ **Sách chuyên khảo:** Tìm trên Google Books và các nhà xuất bản y khoa.
- ✓ **Nguồn mở trên internet:** Các trang uy tín như nursingworld.org (ANA), suckhoedoisong.vn, và một số trang tạp chí mở.

Trong số **12 tài liệu được tham khảo**, trong đó có **6 bài báo khoa học**, Các tài liệu tham khảo có liên quan được đề trong phần “**Tài liệu tham khảo**” được đề ở cuối bài luận. **10 tài liệu chính** em chọn để báo cáo cho bài tập này (đã lọc bỏ trùng lặp và ít liên quan nhất). (Xem phần phụ lục 1, 2).

3 Ưu điểm và nhược điểm của Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) và hồ sơ giấy.

3.1 Ưu điểm của EHR:

- Lưu trữ thông tin bệnh nhân dưới dạng kỹ thuật số, dễ tìm kiếm, dễ chia sẻ giữa các cơ sở y tế.
- Hạn chế sai sót trong kê đơn thuốc nhờ hệ thống cảnh báo và quy trình nhập dữ liệu chuẩn hóa. Hệ thống có thể tự động cảnh báo khi phát hiện nguy cơ tương tác thuốc hoặc khi bệnh nhân có tiền sử dị ứng với một loại thuốc nhất định. Theo [3] (Topaz, M., & Pruinelli, L., 2017) việc sử dụng dữ liệu điện tử trong điều dưỡng có thể giúp cải thiện quá trình theo dõi bệnh nhân và hỗ trợ điều dưỡng viên đưa ra các quyết định chăm sóc chính xác hơn.
- Hỗ trợ nghiên cứu dịch tễ học, quản lý bệnh mãn tính và nâng cao chất lượng chăm sóc điều dưỡng.
- Giúp giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm thời gian cho bác sĩ và điều dưỡng. Khi các quy trình ghi chép và báo cáo được tự động hóa, điều dưỡng viên có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc trực tiếp bệnh nhân, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
- Bệnh nhân có thể tự truy cập hồ sơ của mình, từ đó giúp Bệnh nhân tự nâng cao sự chủ động trong quản lý sức khỏe.

3.2 Hạn chế của EHR:

- Nguy cơ **rò rỉ thông tin** nhạy cảm nếu bảo mật không tốt bởi tin tặc.
- Công tác **hợp chuẩn dữ liệu** có thể gây khó khăn cho một số cơ sở y tế địa phương do mặt bằng trình độ sử dụng thiết bị công nghệ cũng như phần mềm.
- Sẽ xuất hiện **nhóm Bệnh nhân** có thể lo lắng hoặc nhầm lẫn khi tự đọc kết quả xét nghiệm mà chưa được giải thích bởi Bác sĩ hoặc người có chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.
- Việc chuyển sang dùng hồ sơ sức khỏe điện tử thường chưa chú ý nhiều đến ảnh hưởng của nó đối với sự giao tiếp giữa điều dưỡng và bệnh nhân. Có nghiên cứu cho thấy EHR có tác động, nhưng cũng có cách để giảm bớt tác động này. Vì vậy, trong tương lai, điều dưỡng cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn và xây dựng các biện pháp nhằm giữ vững vai trò quan trọng của giao tiếp và tương tác với bệnh nhân [4] (Carol Forde-Johnston et al. (Oxford Brookes University, UK) , 2022).

3.3 Ưu điểm của Hồ sơ giấy:

- Ít rủi ro về bảo mật điện tử vì không phụ thuộc vào hệ thống mạng.
- Phổ quát với các nhân viên y tế, cũng như Bệnh nhân và người nhà Bệnh nhân do đã quen sử dụng từ lâu.

3.4 Hạn chế của Hồ sơ giấy:

- Dễ bị thất lạc, khó đọc (chữ viết tay, viết ẩu), dễ gây sai sót trong ghi chép thuốc và điều trị.
- Tốn thời gian tìm kiếm, khó chia sẻ giữa các cơ sở y tế.
- Tốn vật tư như: giấy in, mực in, máy in, kho lưu trữ tài liệu...

4 Áp dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống EHR

4.1 Trí tuệ nhân tạo là gì?

Trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực công nghệ giúp máy tính thực hiện các nhiệm vụ trí tuệ như học tập, suy luận, và ra quyết định. Nó ra đời từ thập niên 1950 với những nghiên cứu đầu tiên của Alan Turing và các nhà khoa học máy tính, sau đó phát triển mạnh mẽ qua nhiều giai đoạn nhờ sự tiến bộ của máy tính và thuật toán. AI hiện diện rộng rãi trong đời sống, từ trợ lý ảo, xe tự lái đến y tế và tài chính.

4.2 Sự phát triển của AI trong EHR

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã mở rộng đáng kể khả năng khai thác dữ liệu từ hệ thống EHR. AI có khả năng phân tích lượng lớn dữ liệu y tế trong thời gian ngắn và phát hiện các mẫu dữ liệu hoặc xu hướng bệnh lý mà con người khó nhận ra.

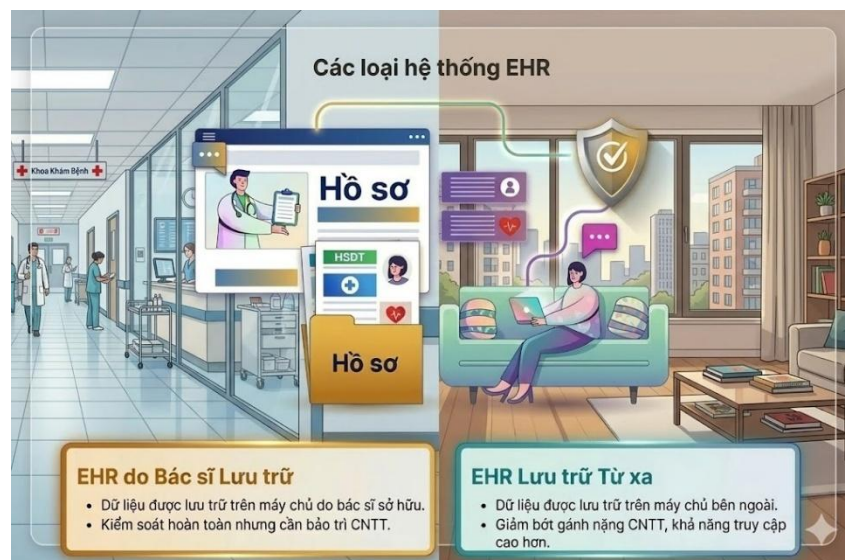
Một trong những ứng dụng quan trọng của AI là hỗ trợ ra quyết định lâm sàng. Các thuật toán học máy có thể phân tích dữ liệu từ EHR để dự đoán nguy cơ mắc bệnh hoặc biến chứng của bệnh nhân. Theo Wang, Kung và Byrd (2018), [2] việc ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong y tế có thể giúp cải thiện hiệu quả chẩn đoán và hỗ trợ nhân viên y tế đưa ra quyết định chính xác hơn.

AI cũng có thể hỗ trợ tự động hóa việc ghi chép hồ sơ y tế. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) cho phép chuyển đổi các cuộc trò chuyện giữa bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân thành dữ liệu có cấu trúc trong EHR. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian nhập liệu thủ công.

Ngoài ra, AI còn được sử dụng để phân tích dữ liệu sức khỏe cộng đồng. Thông qua việc tổng hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều bệnh nhân, hệ thống AI có thể phát hiện sớm các xu hướng dịch bệnh hoặc các yếu tố nguy cơ trong cộng đồng. Điều này giúp các cơ quan y tế xây dựng các chiến lược phòng ngừa và kiểm soát bệnh hiệu quả hơn.

5 Các dạng hệ thống EHR

Tùy theo cách lưu trữ và quản lý dữ liệu thì Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) có nhiều dạng khác nhau. Hai dạng phổ biến nhất là EHR do bác sĩ lưu trữ tại cơ sở y tế (**Physician- host EHR**) và **EHR lưu trữ từ xa** trên hệ thống của bên thứ ba (**Remotly-Host EHR**). Ngoài ra, còn có EHR theo chiều dọc (**Longitudinal EHR**) cho phép dữ liệu bệnh nhân được liên thông xuyên suốt giữa các cơ sở y tế, đã áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.



Hình 2: Định dạng hệ thống EHR (Nguồn Tạo bằng AI Gemini)

6 Thách thức trong việc triển khai EHR và AI

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc phát triển EHR và AI trong hệ thống y tế vẫn gặp một số thách thức đáng kể là chi phí đầu tư ban đầu cao, bao gồm chi phí hạ tầng công nghệ, phần mềm và đào tạo nhân viên.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu y tế cũng là một mối quan tâm quan trọng. Dữ liệu sức khỏe của bệnh nhân là thông tin nhạy cảm, do đó cần có các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc rò rỉ thông tin.

Việc ứng dụng AI trong y tế cũng cần lưu ý về đạo đức và trách nhiệm pháp lý. Các hệ thống AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu và đưa ra gợi ý, **nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải do nhân viên y tế có chuyên môn đưa ra.**

Hiện tại, các điều dưỡng viên mới tốt nghiệp bước vào nghề trong bối cảnh ngành y tế đang thiếu nhân lực nghiêm trọng. Dù nhiều người cho rằng thế hệ **gen Y và Z** am hiểu công nghệ sẽ dễ dàng sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR), Các nghiên cứu cho thấy sinh viên điều dưỡng hiện nay chưa được chuẩn bị đầy đủ cho **môi trường chăm sóc sức khỏe số**. Thực tế, nhiều điều dưỡng viên mới đánh giá quá cao kỹ năng EHR của mình, và việc quen thuộc với công nghệ không đồng nghĩa với tự tin khi dùng EHR [5] (Jennifer Wilks, 2025).

7 Kết luận

Qua quá trình tìm hiểu, em nhận thấy hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là một lĩnh vực công nghệ quan trọng trong chuyển đổi số ngành y tế. Việc áp dụng EHR trong chăm sóc điều dưỡng giúp công tác quản lý thông tin bệnh nhân hiệu quả hơn, hỗ trợ phối hợp giữa các nhân viên y tế và giảm sai sót trong điều trị.

Để tận dụng tối đa lợi ích của EHR thì các cơ sở y tế cần đầu tư hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân lực chuyên ngành này và chú trọng bảo mật dữ liệu. Ngoài ra, cần đầu tư phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) để mở ra khả năng khai thác dữ liệu EHR trong việc dự đoán nguy cơ bệnh tật, hỗ trợ ra quyết định khám bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán lâm sàng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Trong tương lai gần, sự kết hợp giữa EHR, công nghệ số, AI sẽ ngày càng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với vai trò cử nhân điều dưỡng, việc hiểu rõ **ưu điểm và nhược điểm** của EHR so với hồ sơ giấy giúp chúng em phối hợp tốt hơn trong chăm sóc bệnh nhân. Đây cũng là nội dung phù hợp với **ngành học Điều dưỡng**, vì EHR là công cụ hỗ trợ quan trọng trong quản lý dữ liệu bệnh nhân, giảm lỗi và nâng cao chất lượng chăm sóc.

8 TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Gunter TD, Terry NP, March 2005. The emergence of national electronic health record architectures in the United States and Australia: models, costs, and questions. *Journal of Medical Internet Research*.
- [2] Wang, Y., Kung, L., & Byrd, T. A., 2018. Big data analytics: Understanding its capabilities and potential benefits for healthcare organizations.. *Technological Forecasting and Social Change*, , pp. 126, 3–13.
- [3] Topaz, M., & Pruinelli, L. , 2017. Big data and nursing: Implications for the future.. *Studies in Health Technology and Informatics*., pp. 232, 165–171.
- [4] Carol Forde-Johnston et al. (Oxford Brookes University, UK) , 2022. An integrative review exploring the impact of Electronic Health Records (EHR) on the quality of nurse–patient interactions and communication.. *Journal of Advanced Nursing published by John Wiley & Sons Ltd*.
- [5] Jennifer Wilks, M. (. C. H., 2025. Best Practices in Training Nurses to Use Electronic Health Records: A Literature Review.. *Frontiers in Public Health*.
- [6] Ze Luan et al (Jilin University, Trung Quốc), 2023. Electronic health records in nursing from 2000 to 2020: A bibliometric analysis.. *Frontiers in Public Health*.

9 Phụ lục 1: Đánh giá độ tin cậy của từng nguồn

Em đánh giá theo 5 tiêu chí:

- ✓ Tác giả (chuyên môn, bằng cấp).
- ✓ Cơ quan xuất bản (tạp chí hay trang báo phổ thông).
- ✓ Phương pháp nghiên cứu (systematic review, bibliometric...).
- ✓ Trích dẫn (số lượng trích dẫn cao => ảnh hưởng lớn).
- ✓ Tính cập nhật (2022 trở lên => cao).

Bảng tổng hợp các nguồn thông tin

STT	Tên tài liệu (Title)	Tác giả / Nguồn	Năm xuất bản	Đánh giá độ tin cậy	Xếp hạng độ tin cậy
1	An integrative review exploring the impact of Electronic Health Records (EHR) on the quality of nurse–patient interactions and communication	Carol Forde-Johnston et al. (Oxford Brookes University, UK) – Journal of Advanced Nursing (peer-reviewed)	2022	Tác giả: giảng viên đại học + bệnh viện; Xuất bản: tạp chí Q1; Phương pháp: phân tích 8 nghiên cứu; Trích dẫn: cao; Cập nhật: tốt.	Cao
2	Best Practices in Training Nurses to Use Electronic Health Records: A Literature Review	Jennifer Wilks, MHS (Vancouver Coastal Health) – Canadian Journal of Nursing Informatics	2025	Tác giả: chuyên gia giáo dục lâm sàng; Xuất bản: tạp chí chuyên ngành điều dưỡng tin học; Phương pháp: phân tích các nghiên cứu (15 bài từ CINAHL, MEDLINE); Cập nhật: rất mới.	Cao
3	Electronic health records in nursing from 2000 to 2020: A bibliometric analysis	Ze Luan et al. (Jilin University, Trung Quốc) – Frontiers in Public Health	2023	Tác giả: nhóm nghiên cứu trường y; Xuất bản: Frontiers (open access Q1); Phương pháp: tham khảo học (2616 bài); Trích dẫn: rất cao (h-index 70); Cập nhật: tốt.	Cao
4	Nursing informatics and patient safety outcomes in critical care settings: a systematic review	Qian Shi et al. (Monash University, Australia) – BMC Nursing (Springer)	2025	Tác giả: giảng viên điều dưỡng; Xuất bản: Springer Phương pháp: Đánh giá có hệ thống - theo JBI (17 bài chất lượng cao); Trích dẫn: 6 trích dẫn + 30k truy cập; Cập nhật: mới nhất.	Cao
5	The development and impact of adopting electronic health records in the United States: A brief overview and implications for nursing education	Ge et al. – Health Care Science (Wiley)	2022	Tác giả: nhóm nghiên cứu Mỹ; Xuất bản: Wiley; Phương pháp: Tổng quan + phân tích; Cập nhật: tốt.	Cao

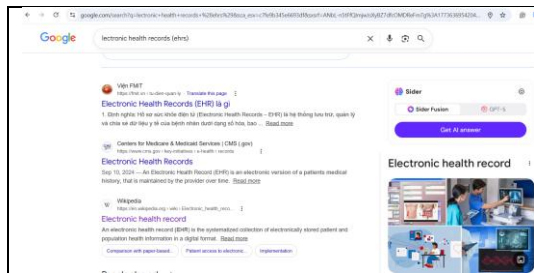
6	Experiences of Electronic Health Records' and Client Information Systems' Use on a Mobile Device...	Nhóm tác giả JMIR – Journal of Medical Internet Research	2024	Tác giả: nghiên cứu định lượng; Xuất bản: JMIR (Q1); Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang; Cập nhật: tốt.	Cao
7	Nursing Informatics and the Foundation of Knowledge (6th Edition)	Dee McGonigle & Kathleen Mastrian – Jones & Bartlett Learning	2024	Tác giả: chuyên gia hàng đầu thế giới về nursing informatics; Xuất bản: nhà xuất bản y khoa uy tín; Nội dung: sách giáo trình chuẩn; Cập nhật: phiên bản mới nhất.	Cao
8	What Is Nursing Informatics and Why Is It So Important?	American Nurses Association (ANA) – nursingworld.org	2023	Tác giả: tổ chức nghề nghiệp quốc gia Mỹ; Xuất bản: trang chính thức của ANA; Phương pháp: bài tổng quan; Cập nhật: tốt.	Trung bình (nguồn chuyên môn nhưng không phải bài báo nghiên cứu)
9	The emergence of national electronic health record architectures in the United States and Australia: models, costs, and questions	Gunter TD, Terry NP (March 2005). Journal of Medical Internet Research	2005	Tác giả: chuyên gia hàng đầu thế giới về nursing informatics; Xuất bản: Tạp chí nghiên cứu y tế trên Internet; Phương pháp: bài thực hành; Cập nhật: hơi cũ.	Trung bình
10	Điều dưỡng tin học - kết nối giữa công nghệ thông tin và chăm sóc sức khỏe	P.H. - suckhoedoisong.vn	2019	Tác giả: không nêu bằng cấp; Xuất bản: báo mạng phổ thông; Phương pháp: bài giới thiệu; Cập nhật: cũ	Thấp (chỉ dùng tham khảo khái niệm cơ bản)

Kết luận đánh giá tổng quát:

- ✓ **6/10 tài liệu xếp hạng Cao** (chủ yếu bài báo khoa học gần đây, phương pháp nghiên cứu nghiêm ngặt, tác giả có chuyên môn cao) rất đáng tin cậy để viết báo cáo hoặc luận văn sau này.
- ✓ Các nguồn tạp chí quốc tế (Frontiers, BMC, Journal of Advanced Nursing) và sách chuyên khảo là nền tảng vững chắc nhất.
- ✓ Nguồn Việt Nam hiện còn hạn chế (chủ yếu bài phổ thông), nên em sẽ ưu tiên tài liệu quốc tế và dịch sang tiếng Việt khi áp dụng thực tế tại Việt Nam.
- ✓ Em đã lưu tất cả file PDF (từ PMC, Google Scholar) và ghi chú ngày truy cập (tháng 3/2026) để dễ kiểm tra sau.

10 Phụ lục 2: Hình ảnh tìm dữ liệu – tra cứu dữ liệu – đọc hiểu dữ liệu.

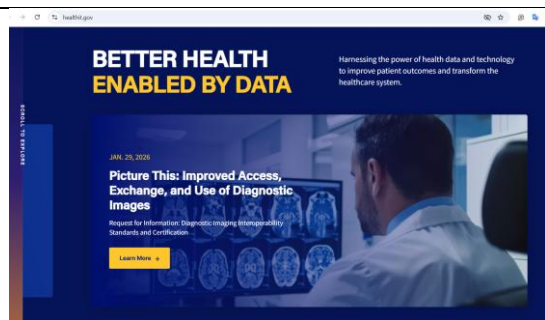
Một số hình ảnh minh họa về cách tìm và tra cứu dữ liệu được trình bày trong các hình dưới đây:



Ảnh 1: Tìm kiếm google với từ khóa: “**electronic health records (ehrs)**”

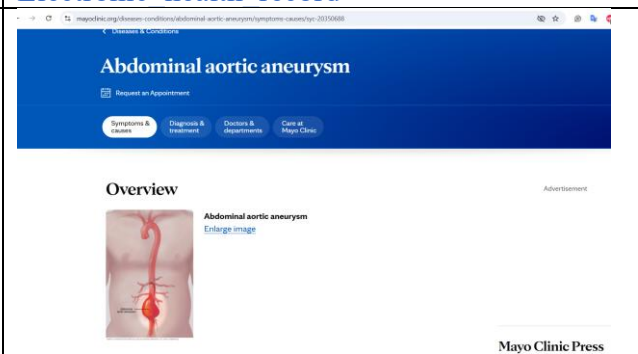


Tra cứu dữ liệu trên trang:
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_health_record



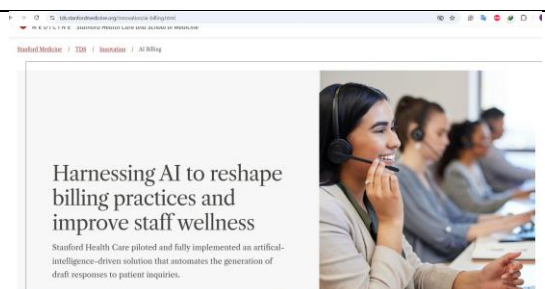
Trang website: <https://www.healthit.gov/>.

Mô tả cách EHR cho phép bác sĩ xem xét nghiệm, đơn thuốc và lịch sử bệnh ngay trên hệ thống điện tử, thay cho hồ sơ giấy.



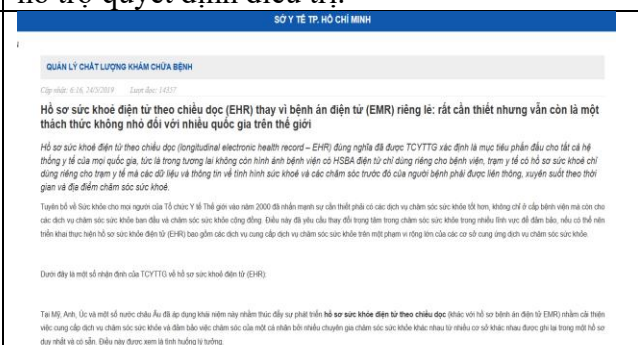
Trang website: <https://www.mayoclinic.org/>.

Mô tả cách EHR giúp bác sĩ và điều dưỡng truy cập thông tin bệnh nhân nhanh chóng để hỗ trợ quyết định điều trị.

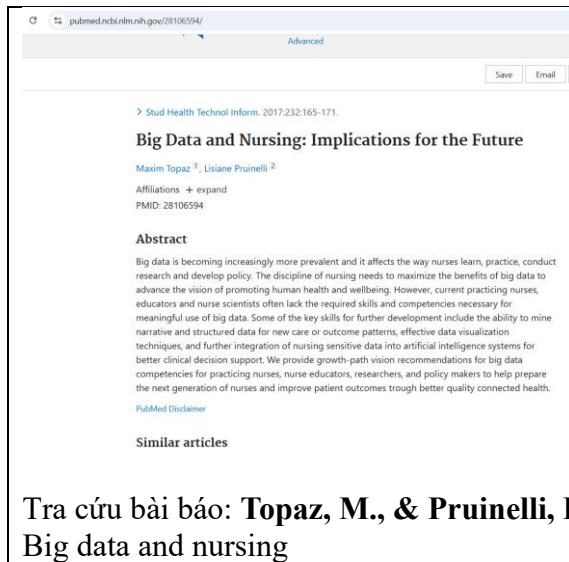


<https://med.stanford.edu/>

Trường có nhiều nghiên cứu về machine learning trên dữ liệu EHR để dự đoán bệnh tim, tiểu đường và tử vong sớm



Hồ sơ sức khỏe điện tử được quản lý theo chiều dọc tại Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh



Stud Health Technol Inform. 2017;232:165-171.

Big Data and Nursing: Implications for the Future

Maxim Topaz¹, Lisiane Pruinelli²

Affiliations + expand
PMID: 28106594

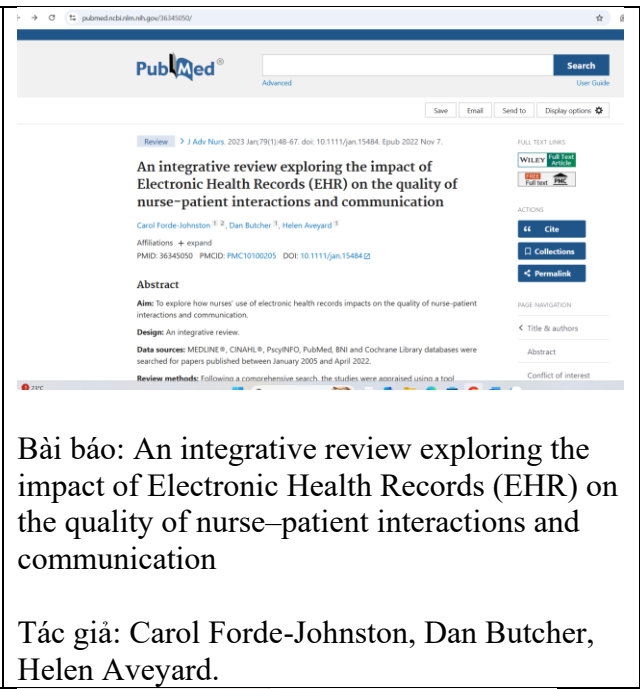
Abstract

Big data is becoming increasingly more prevalent and it affects the way nurses learn, practice, conduct research and develop policy. The discipline of nursing needs to maximize the benefits of big data to advance the vision of promoting human health and wellbeing. However, current practicing nurses, educators and nurse scientists often lack the required skills and competencies necessary for meaningful use of big data. Some of the key skills for further development include the ability to mine narrative and structured data for new care or outcome patterns, effective data visualization techniques, and further integration of nursing sensitive data into artificial intelligence systems for better clinical decision support. We provide growth-path vision recommendations for big data competencies for practicing nurses, nurse educators, researchers, and policy makers to help prepare the next generation of nurses and improve patient outcomes through better quality connected health.

PubMed Disclaimer

Similar articles

Tra cứu bài báo: **Topaz, M., & Pruinelli, L. (2017).**
Big data and nursing



Pubmed

Search

Advanced

Save Email Send to Display options

Review > J Adv Nurs. 2023 Jan;79(1):48-67. doi: 10.1111/jan.15484. Epub 2022 Nov 7.

An integrative review exploring the impact of Electronic Health Records (EHR) on the quality of nurse-patient interactions and communication

Carol Forde-Johnston^{1,2}, Dan Butcher³, Helen Aveyard⁴

Affiliations + expand
PMID: 36345850 PMCID: PMC10100205 DOI: 10.1111/jan.15484

Abstract

Aims: To explore how nurses' use of electronic health records impacts on the quality of nurse-patient interactions and communication.

Design: An integrative review.

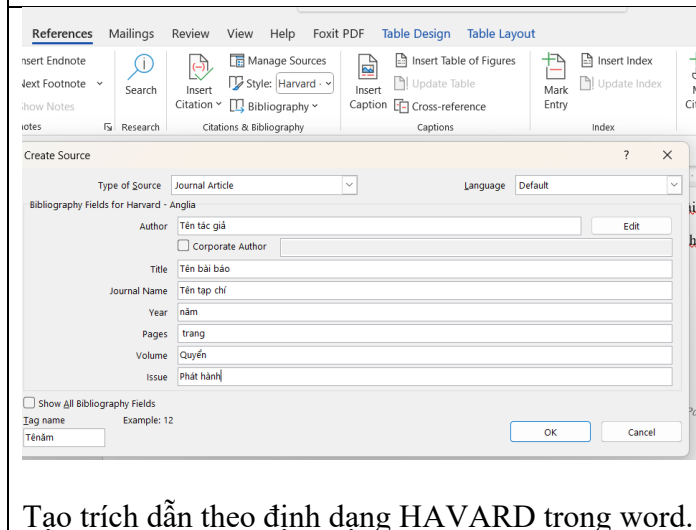
Data sources: MEDLINE®, CINAHL®, PsycINFO, PubMed, BNI and Cochrane Library databases were searched for papers published between January 2005 and April 2022.

Review methods: Following a comprehensive search, the studies were analysed using a tool

Conflict of interest

Bài báo: An integrative review exploring the impact of Electronic Health Records (EHR) on the quality of nurse-patient interactions and communication

Tác giả: Carol Forde-Johnston, Dan Butcher, Helen Aveyard.



References Mailings Review View Help Foxtit PDF Table Design Table Layout

Insert Endnote
Text Footnote
Show Notes
Notes

Search
Insert
Citation
Bibliography

Style: Harvard
Insert
Caption
Cross-reference
Captions
Index

Create Source

Type of Source: Journal Article
Language: Default

Bibliography Fields for Harvard - Anglia

Author: Tên tác giả
Corporate Author

Title: Tên bài báo

Journal Name: Tên tạp chí

Year: năm

Pages: trang

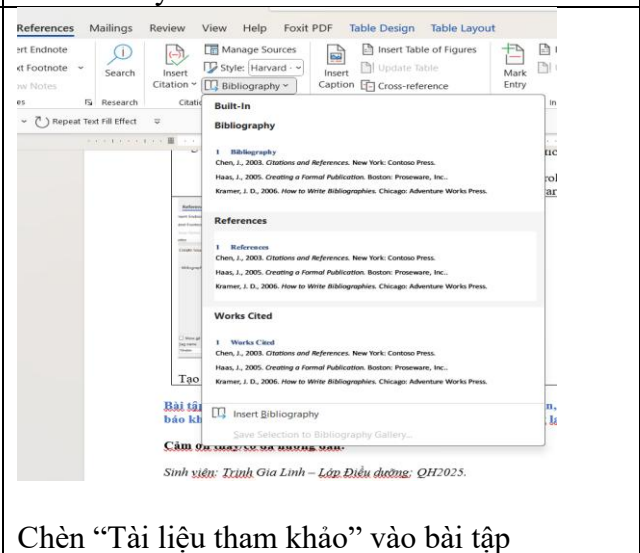
Volume: Quyển

Issue: Phát hành

Show All Bibliography Fields
Tag name: Example: 12
Tên năm

OK Cancel

Tạo trích dẫn theo định dạng HAVARD trong word.



References Mailings Review View Help Foxtit PDF Table Design Table Layout

Insert Endnote
Text Footnote
Show Notes
Notes

Search
Insert
Citation
Bibliography

Style: Harvard
Insert
Caption
Cross-reference
Captions
Index

Built-in Bibliography

1. Bibliography
Chen, J., 2003. Citations and References. New York: Cengage Press.
Haas, J., 2005. Creating a Formal Publication. Boston: Proseware, Inc.
Kramer, J. D., 2006. How to Write Bibliographies. Chicago: Adventure Works Press.

References

1. References
Chen, J., 2003. Citations and References. New York: Cengage Press.
Haas, J., 2005. Creating a Formal Publication. Boston: Proseware, Inc.
Kramer, J. D., 2006. How to Write Bibliographies. Chicago: Adventure Works Press.

Works Cited

1. Works Cited
Chen, J., 2003. Citations and References. New York: Cengage Press.
Haas, J., 2005. Creating a Formal Publication. Boston: Proseware, Inc.
Kramer, J. D., 2006. How to Write Bibliographies. Chicago: Adventure Works Press.

Bài tập
báo k
Cảm ơn thầy/cô đã hướng dẫn!

Sinh viên: Trịnh Gia Linh – Lớp Điều dưỡng: QH2025.

Chèn “Tài liệu tham khảo” vào bài tập

Bài tập này giúp em hiểu rõ hơn cách tìm kiếm, đánh giá nguồn tin, kỹ năng soạn thảo bài báo khoa học – kỹ năng rất quan trọng khi làm điều dưỡng tương lai.

Cảm ơn thầy/cô đã hướng dẫn!

Sinh viên: Trịnh Gia Linh – Lớp Điều dưỡng: QH2025.ĐD